Lekári nežiadajú iba vyšší plat. Čoraz častejšie žiadajú späť kontrolu nad vlastným časom

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.08.2026



Ilustračná scéna. Peniaze nie sú jadrom problému – jadrom je, kto rozhoduje o lekárovom čase.

Prieskum medzi lekármi ukazuje, že čas, predvídateľnosť a autonómia sa stávajú súčasťou toho, ako lekári hodnotia pracovné miesto. Zaujímavejšia než samotné percento je však otázka, čo s tým robiť. Dostupné dôkazy tu hovoria pomerne jednoznačne: riešenie neleží na strane jednotlivca.

Takmer šesť z desiatich lekárov oslovených v prieskume spoločnosti Medscape uviedlo, že by boli ochotní prijať nižší plat výmenou za lepšie zosúladenie pracovného a osobného života alebo za viac voľného času. Podľa prezentovaných výsledkov by nižší príjem zvážilo **59 % lekárov**, kým v predchádzajúcom prieskume to bolo 63 %. Súčasne **46 % respondentov** uviedlo vyhorenie, depresiu alebo kombináciu oboch stavov.

Tento výsledok nemožno čítať ako dôkaz, že väčšina lekárov by v konkrétnej pracovnej ponuke skutočne súhlasila so znížením príjmu. Je to však významný signál o tom, že finančná kompenzácia nedokáže neobmedzene nahrádzať stratu času a kontroly nad vlastným životom.

Čo lekári označili za dôležité

Približne tri štvrtiny respondentov pripisovali veľký význam času strávenému s rodinou a možnosti čerpať dovolenku. Asi osem z desiatich považovalo záujmové aktivity za dôležité alebo veľmi dôležité pre relaxáciu a duševné zdravie.

Lekári teda spravidla dobre vedia, čo podporuje ich regeneráciu – dostatok spánku, čas s blízkymi, pohyb, kvalitná strava, záujmy, dovolenka bez pracovného vyrušovania a primeraná kontrola nad pracovným časom. **Problémom nie je nedostatok vedomostí o zdravom životnom štýle, ale nemožnosť uplatniť ich v pracovnom prostredí.** Povinnosti pokračujú aj po skončení formálnej pracovnej doby prostredníctvom dokumentácie, elektronickej komunikácie, výsledkov vyšetrení a zodpovednosti za pacientov.

Vyhorenie nie je synonymom depresie

Zdrojový článok spája do jedného čísla respondentov, ktorí uviedli vyhorenie, depresiu alebo obidva stavy. Z klinického hľadiska však ide o odlišné konštrukty a spoločné vykazovanie ich zmysel stiera.

Pracovné vyhorenie je syndróm súvisiaci s chronickým pracovným stresom. Typicky zahŕňa emocionálne vyčerpanie, psychický odstup alebo cynizmus voči práci a znížený pocit profesionálnej účinnosti. Nejde o samostatnú medicínsku diagnózu v rovnakom zmysle ako depresívna porucha.

Depresívna porucha je klinické ochorenie, ktoré zasahuje náladu, schopnosť prežívať radosť, spánok, chuť do jedla, psychomotoriku, kognitívne funkcie, sebahodnotenie a suicidálne riziko. Jej prejavy nie sú viazané na pracovné prostredie.

Obidva stavy sa môžu prekrývať a navzájom zhoršovať. Zo spoločnej kategórie však **nemožno určiť, koľko respondentov spĺňalo diagnostické kritériá depresívnej poruchy**. Údaj 46 % teda v žiadnom prípade neznamená, že 46 % lekárov malo klinicky diagnostikovanú depresiu.

Je nižší plat riešením?

Ochota zvážiť nižší príjem vyjadruje, akú hodnotu lekári pripisujú času a autonómii. Samotné zníženie mzdy však nie je intervenciou proti vyhoreniu, je to len zníženie mzdy.

Ak by sa rovnaký objem práce, rovnaká administratívna záťaž a rovnaká zodpovednosť spojili s nižším platom, výsledkom by bolo ďalšie zhoršenie pracovnej spokojnosti. Zmysluplná výmena musí znamenať **reálne zníženie pracovného zaťaženia alebo zvýšenie kontroly nad pracovným režimom** – kratší alebo flexibilnejší úväzok, menej služieb, predvídateľný rozpis, chránený voľný čas, obmedzenie administratívy po pracovnej dobe, primeraný počet pacientov a dostatočné personálne zabezpečenie.

Osobitne opatrne treba výsledky vykladať pri lekároch s nižším príjmom, v špecializačnej príprave, u rodičov, samoživiteľov a osôb zaťažených úvermi. **Nie každý si môže dovoliť vymeniť čas za nižšiu mzdu.** Preferencia lepšieho pracovného režimu preto neznamená ekonomickú možnosť takúto ponuku prijať – a prieskum meria to prvé, nie druhé.

Hypotetický súhlas nie je rozhodnutie

Otázka zisťovala deklarovanú ochotu, nie reálne správanie. Medzi hypotetickou odpoveďou a prijatím konkrétnej ponuky býva podstatný rozdiel. V praxi by rozhodovanie ovplyvnil rozsah zníženia príjmu, skutočný počet ušetrených hodín, počet a charakter služieb, náklady na bývanie a starostlivosť o rodinu, poistenie a dôchodkové zabezpečenie, profesijná zodpovednosť, možnosť skráteného úväzku bez kariérnej penalizácie a najmä **dôvera, že zamestnávateľ dohodnutý voľný čas naozaj dodrží**.

Bez poznania týchto parametrov nemožno z hodnoty 59 % odvodiť nič o tom, akú časť príjmu by boli lekári ochotní reálne obetovať.

Prečo individuálna odolnosť nestačí

Pri tejto otázke už máme tvrdé dôkazy a hovoria dosť jasne.

Systematický prehľad a metaanalýza kontrolovaných intervencií, ktorú publikovala Maria Panagiotiová so spolupracovníkmi, zahrnula 20 porovnaní z 19 štúdií s 1550 lekármi. Intervencie viedli k malému, ale významnému zníženiu vyhorenia (štandardizovaný rozdiel priemerov −0,29), pričom rozhodujúci bol ich typ:

- **organizačne zamerané intervencie: −0,45** (95 % IS −0,62 až −0,28),
- **intervencie zamerané na jednotlivého lekára: −0,18** (95 % IS −0,32 až −0,03).

Organizačné zásahy teda boli približne dvaapolkrát účinnejšie. Autori z toho vyvodili, že vyhorenie je **problémom zdravotníckej organizácie, nie jednotlivcov**.

Novšia metaanalýza intervencií u lekárov v špecializačnej príprave (33 štúdií, 2536 účastníkov) však priniesla striedmejší obraz. Individuálne intervencie mali malý účinok na emocionálne vyčerpanie (Cohenovo d −0,25; 95 % IS −0,40 až −0,11) a na depersonalizáciu (−0,17; 95 % IS −0,32 až −0,03), zatiaľ čo **organizačné intervencie nepreukázali významný účinok v žiadnej doméne**. Podiel organizačných intervencií bol pritom

v tejto analýze nízky – tvorili menej než štvrtinu zaradených štúdií.

Zdanlivý rozpor medzi oboma prácami sa dá vysvetliť. Výsledky skôr ukazujú, že:

1. nie každá organizačná zmena je účinná – označenie „organizačná intervencia“ zahŕňa všetko od skutočnej zmeny rozpisu po formálny workshop;
2. výsledok závisí od konkrétneho pracoviska a od toho, ako dôsledne sa zmena realizovala;
3. krátkodobá alebo formálna intervencia neodstráni základnú príčinu, ktorou je chronický nepomer medzi objemom práce a zdrojmi;
4. populácia lekárov v príprave má vlastné špecifiká – obmedzenú možnosť ovplyvniť rozpis a vysokú fluktuáciu prostredia.

Praktický záver z oboch prác je zhodný: samotné programy duševnej pohody problém nevyriešia, ale ani formálna organizačná zmena bez skutočného zníženia záťaže neprinesie výsledok.

Čo by mali organizácie meniť

Predvídateľný pracovný režim

Predvídateľnosť môže byť rovnako dôležitá ako počet hodín. Časté zmeny rozpisu, neočakávané služby a chronická pohotovosť narúšajú spánok, rodinné vzťahy aj možnosť plánovať odpočinok.

Skutočne chránené voľno

Dovolenka stráca zmysel, ak lekár naďalej vybavuje výsledky, elektronické správy a telefonáty. Chránené voľno vyžaduje zastupiteľnosť a jasné odovzdanie zodpovednosti – nie apel, aby si lekár „nepozeral mobil“.

Zníženie administratívnej záťaže

Administratíva, duplicita záznamov a neefektívne informačné systémy predlžujú pracovný deň bez prínosu pre pacienta. Zmysluplná digitalizácia má obmedziť opakované zadávanie údajov, nie preniesť ďalšiu prácu na lekára.

Primeraný počet pracovníkov

Programy duševnej pohody nemôžu kompenzovať chronický personálny deficit. Ak menší počet pracovníkov dlhodobo zabezpečuje rovnaký alebo rastúci objem starostlivosti, individuálna psychohygiena má obmedzený účinok.

Autonómia a účasť na rozhodovaní

Možnosť ovplyvniť rozpis, organizáciu ambulancie, počet pacientov a klinické procesy býva významnou súčasťou spokojnosti. Autonómia však nesmie znamenať prenesenie systémovej zodpovednosti na jednotlivca bez zodpovedajúcich zdrojov.

Meranie výsledkov

Organizácia by nemala sledovať iba účasť na programe, ale jeho dôsledky: skutočný pracovný čas vrátane neplatenej práce po službe, počet služieb a zmien rozpisu, fluktuáciu a odchody, práceneschopnosť, čerpanie dovolenky, profesionálnu spokojnosť, jednotlivé dimenzie vyhorenia a bezpečnosť a kontinuitu starostlivosti.

Osobitosti nefrológie

Nefrológia patrí medzi odbory s vysokou mierou kontinuálnej zodpovednosti. Dialyzovaní pacienti potrebujú pravidelnú a časovo viazanú liečbu, pričom akútne komplikácie, hospitalizácie, transplantácie a zastupovanie nemožno jednoducho odložiť.

Rizikovými organizačnými faktormi bývajú:

- nedostatok nefrológov a dialyzačných sestier,
- súbežná ambulantná, nemocničná a dialyzačná agenda,
- vysoký počet medicínsky zložitých pacientov,
- časté pohotovostné konzultácie,

- administratíva spojená s predpisovaním a vykazovaním liečby,
- emocionálna záťaž dlhodobej starostlivosti a rozhodovania na konci života,
- obmedzená zastupiteľnosť počas dovoleniek a práceneschopnosti.

Posledný bod je v malých tímoch určujúci. Ak dialyzačné stredisko funguje s dvoma nefrológmi, neexistuje spôsob, ako jednému z nich zabezpečiť skutočne chránené voľno bez toho, aby sa záťaž presunula na druhého. Riešením preto nemôže byť odporúčanie, aby nefrológ lepšie odpočíval – potrebné sú zastupiteľné tímy, primerané personálne normy a reálne oddelenie pracovného a voľného času.

Metodické obmedzenia prieskumu

- Zdrojový článok neposkytuje úplný opis výberu respondentov ani mieru návratnosti.
- Nie je jasné, nakoľko sú respondenti reprezentatívni pre lekársku populáciu – samovýber do online prieskumu spravidla nadhodnocuje zastúpenie tých, ktorých téma zasahuje.
- Údaje sú založené na sebahodnotení.
- Ochota prijať nižší plat bola hypotetická a nebolo uvedené, o aké zníženie by malo ísť.
- Spoločná kategória „vyhorenie, depresia alebo oboje“ spája odlišné klinické a pracovné problémy.
- Prierezový dizajn neumožňuje doložiť, že nedostatok voľného času tieto ťažkosti priamo spôsobil.
- Medzinárodná prenositeľnosť je obmedzená rozdielmi v odmeňovaní, pracovnom práve a organizácii zdravotníctva – americké údaje nemožno bez výhrad prenášať do slovenských podmienok.

Presnejšie je preto hovoriť o **silnom signáli pracovných preferencií** než o populačnom odhade.

Záver

Prieskum naznačuje, že významná časť lekárov nevníma odmenu iba ako mzdu. Predvídateľný pracovný čas, možnosť regenerácie, chránená dovolenka, autonómia a život mimo pracoviska majú vlastnú hodnotu.

Výsledok však nie je požiadavkou na zníženie platov. Lekári nežiadajú, aby bola ich práca ocenená menej – signalizujú, že peniaze nedokážu donekonečna nahrádzať stratu času, vzťahov a zdravia.

Udržateľnosť lekárskeho povolania preto vyžaduje primerané odmeňovanie **aj** pracovné podmienky umožňujúce kvalitnú starostlivosť bez chronického vyčerpania. Dostupné metaanalytické dôkazy pritom naznačujú, že podstatná časť riešenia leží na úrovni pracoviska a systému – nie v odporúčaniach o odolnosti a psychohygiene adresovaných jednotlivému lekárovi.

Súvisiace články

- AI scribe v ambulancii – možnosti a právne nástrahy pri znižovaní administratívnej záťaže.
- Spolupráca všeobecného lekára a nefrológa – organizácia starostlivosti pri CKD.
- Dvanásť kníh o lekárovi, chorobe a pacientovi – naratívna medicína.

Zdroje

1. **Jennifer Nelson.** *Doctors Aren't Asking for More Money. They're Asking for Their Lives Back.* Medscape, 2026. Medscape.
2. **Maria Panagioti, Efharis Panagopoulou, Peter Bower, George Lewith, Evangelos Kontopantelis, Carolyn Chew-Graham, Shoba Dawson, Harm van Marwijk, Keith Geraghty, Aneez Esmail.** *Controlled Interventions to Reduce Burnout in Physicians: A Systematic Review and Meta-analysis.* JAMA Internal Medicine. 2017;177(2):195–205. doi: 10.1001/jamainternmed.2016.7674. PubMed.
3. **Wuttipat Kiratipaisarl, Vithawat Surawattanasakul, Wachiranun Sirikul.** *Individual and organizational interventions to reduce burnout in resident physicians: a systematic review and meta-analysis.* BMC Medical Education. 2024;24:1234. doi: 10.1186/s12909-024-06195-3. PubMed.

Poznámka k dôkazom: *Bibliografické údaje, kompletné autorstvo aj číselné výsledky oboch metaanalýz boli*

overené v Europe PMC – pri práci Panagiotiovej a spolupracovníkov 20 porovnaní z 19 štúdií s 1550 lekármi, celkový štandardizovaný rozdiel priemerov −0,29 a rozdiel medzi organizačne zameranými (−0,45; 95 % IS −0,62 až −0,28) a na lekára zameranými intervenciami (−0,18; 95 % IS −0,32 až −0,03); pri práci Kiratipaisarla a spolupracovníkov 33 štúdií s 2536 účastníkmi, podiel 75,8 % individuálnych a 24,2 % organizačných intervencií, Cohenovo d −0,25 pre emocionálne vyčerpanie a −0,17 pre depersonalizáciu a neprítomnosť významného účinku organizačných intervencií. ***Údaje z prieskumu Medscape (59 %, 63 % v predchádzajúcom prieskume, 46 %, podiely týkajúce sa rodiny, dovolenky a záujmov) nebolo možné nezávisle overiť*** *– metodika, veľkosť vzorky, návratnosť ani štruktúra respondentov nie sú v dostupnej podobe zverejnené. Nejde preto o populačný odhad. Výklad rozdielu medzi vyhorením a depresívnou poruchou, vysvetlenie zdanlivého rozporu medzi metaanalýzami, odporúčania pre organizácie a nefrologická časť sú* ***vlastným odborným spracovaním****.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=lekari-cas-autonomia-vyhorenie-pracovne-podmienky · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.